GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE
광교바른내과

심근경색 후 베타차단제, 계속 먹을까 끊을까?

심장마비를 겪은 뒤 1년, 약을 계속 먹을지 끊을지를 비교한 ABYSS 연구를 환자 눈높이에서 알아봅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

베타차단제는 왜 먹나요?

심장마비(심근경색) 후 오래전부터 써 온 대표적인 심장 보호약입니다

핵심 설명

베타차단제는 심장을 천천히·부드럽게 뛰게 해서, 심장이 일하는 부담과 산소 소모를 줄여 줍니다. 심근경색을 겪은 심장은 한동안 약해져 있습니다. 베타차단제는 맥박과 혈압을 낮춰 심장을 쉬게 하고, 위험한 부정맥을 줄여 재발과 사망 위험을 낮추는 것으로 오랫동안 알려져 왔습니다. 그래서 많은 분이 심근경색 후 이 약을 처방받습니다.

심장을 쉬게

맥박·혈압 ↓

심장이 천천히 뛰어 산소 소모와 부담이 줄어듭니다.

부정맥 예방

재발 ↓

위험한 심장 리듬 이상을 줄이는 데 도움이 됩니다.

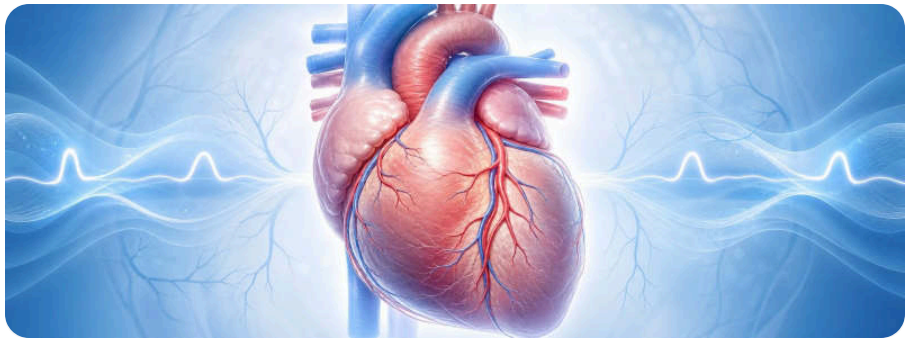


그림 · 베타차단제는 왜 먹나요?

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 심근경색 후 베타차단제의 전통적 역할 · 담당의와 상의하세요

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

그렇다면 평생 먹어야 할까요?

ABYSS 연구가 던진 질문 — 회복이 잘 된 분은 1년 뒤 끊어도 괜찮을까?

핵심 설명

심장 기능이 잘 보존되고 1년간 별문제가 없었다면, 약을 줄이거나 끊어도 안전하지 않을까?라는 궁금증이 있었습니다.
치료가 좋아지면서 요즘은 심근경색 후에도 심장 펌프 기능이 잘 유지되는 분이 많습니다. 약을 줄이면 부작용(피로·어지럼 등)과 약값 부담도 줄겠지요. 그래서 프랑스 연구진이 이 질문에 직접 답하기 위해 ABYSS 연구를 진행했습니다.

3,698명

참여 인원

프랑스 49개 병원, 약 3년간 추적 관찰했습니다.

대상 조건

심기능 양호

심장 펌프 기능(LVEF)이 40% 이상으로 보존된 분.

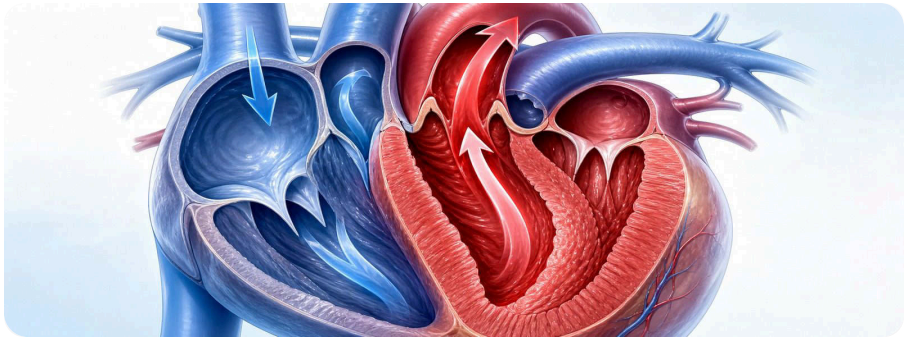


그림 · 그렇다면 평생 먹어야 할까요?

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ABYSS Trial Design · NEJM 2024 (NEJMoa2404204)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

두 그룹으로 나누어 비교했습니다

한쪽은 약을 끊고, 한쪽은 그대로 계속 — 약 3년간 결과를 지켜봤습니다

! 중단 그룹 (약 1,846명)

- 심근경색 약 1년 뒤 베타차단제를 끊음
- 다른 심장약(혈압약·콜레스테롤약 등)은 유지
- "끊어도 안전한지"를 확인하려는 그룹
- 혈압·맥박·증상을 정기적으로 점검

VS

+ 지속 그룹 (약 1,852명)

- 베타차단제를 평소대로 계속 복용
- 기존 표준 치료를 그대로 유지
- 비교의 기준이 되는 그룹
- 같은 방식으로 정기 점검

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ABYSS 무작위 배정 설계 · NEJM 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

끊은 쪽이 더 좋지 않았습니다

사망·심근경색·뇌졸중·심혈관 입원을 합친 사건이 중단 그룹에서 더 많았습니다

23.8%

중단 그룹에서 사망·심근경색·뇌졸중·심혈관 입원을 합친 사건이 23.8% 발생 — 계속 먹은 지속 그룹은 21.1%였습니다.

무슨 뜻인가요

약을 끊은 그룹이 계속 먹은 그룹보다 사건이 더 많았습니다(위험비 약 1.16). 연구진이 목표로 했던 "끊어도 계속과 비슷하다(비열등)"는 기준을 충족하지 못했습니다. 즉, 임의로 끊는 것이 더 낫다는 근거는 나오지 않았습니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ABYSS 1차 복합 평가변수 23.8% vs 21.1% (HR 1.16) · NEJM 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

끊으면 혈압·맥박이 올라갔습니다

ABYSS 2차분석 — 약을 끊은 그룹은 혈압과 맥박이 오르고, 삶의 질은 좋아지지 않았습니다

+10bpm

맥박이 약 10회/분 더 빨라짐

약 +4 mmHg

수축기·이완기 혈압이 함께 올라감

변화 거의 없음

삶의 질(설문)은 끊어도 좋아지지 않음

이 수치가 뜻하는 것

약을 끊으면 부담이 줄어 "더 편해질 것"이라 기대하기 쉽지만, 실제로는 혈압과 맥박이 오르고 삶의 질은 나아지지 않았습니다. 끊어서 얻는 뚜렷한 이득이 확인되지 않은 것입니다. (혈압·맥박 수치는 연구 중간 시점의 평균 변화로, 사람마다 다를 수 있습니다.)

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ABYSS 2차분석 · 혈압 +3.7/3.9mmHg, 심박수 약 +10bpm, 삶의 질(EQ-5D) 차이 없음

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

차이는 주로 '입원'에서 났습니다

사망·심근경색·뇌졸중은 두 그룹이 비슷했고, 심혈관 입원이 중단 그룹에서 더 많았습니다

사망 — 비슷했습니다

중단 4.1% vs 지속 4.0%. 두 그룹의 사망률은 사실상 차이가 없었습니다.

심근경색 재발 — 비슷

중단 2.5% vs 지속 2.4%. 심장마비 재발도 두 그룹이 비슷했습니다.

뇌졸중 — 비슷

중단 1.0% vs 지속 1.0%. 뇌졸중 발생도 차이가 없었습니다.

심혈관 입원 — 중단이 더 많음

중단 18.9% vs 지속 16.6%. 전체 차이는 대부분 '심장 관련 입원'에서 비롯됐습니다.



그림 · 차이는 주로 '입원'에서 났습니다

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ABYSS 구성요소별 결과 · NEJM 2024 (수치는 연구 보고값)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

그래서 내게 어떤 의미인가요?

"끊는 게 이득"이라는 근거는 없었습니다 — 하지만 결정은 사람마다 다릅니다

핵심 설명

이 연구는 "스스로 끊는 것이 더 낫다는 근거는 없다"는 점을 보여 줍니다. 그러나 "모두가 평생 끊으면 안 된다"는 뜻은 아닙니다.

자세히

약을 계속 먹어야 할지, 줄여도 될지는 심장 기능, 혈압, 맥박, 부작용, 다른 질환 등 사람마다 사정이 다릅니다. 같은 검사 결과라도 누군가는 계속이, 누군가는 조정이 맞을 수 있습니다. 이 판단은 반드시 담당 의사와 함께 내려야 합니다.

연구가 말하는 것

끊을 이유 ✕ · 끊어서 더 좋아진다는 증거는 나오지 않았습니다.

연구가 말하지 않는 것

개별 판단 · 내 약 조정은 담당의가 상황을 보고 결정합니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 해석 — 일반적 안내일 뿐, 개인별 처방 변경은 담당의 판단이 우선입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

절대 스스로 끊지 마세요

베타차단제를 갑자기 끊으면 오히려 위험할 수 있습니다 — 조정은 반드시 의사와 함께

갑자기 끊으면 반동 현상이 올 수 있습니다

맥박과 혈압이 갑자기 치솟아 가슴 통증·부정맥 위험이 커질 수 있습니다. 줄일 때도 보통 서서히 감량합니다.

이 약은 여러 이유로 처방됩니다

심근경색뿐 아니라 협심증·부정맥·고혈압·심부전 때문일 수도 있어, 끊으면 안 되는 경우가 많습니다.

부작용이 있어도 임의 중단은 금물

피로·어지럼·맥박 저하 등이 불편하면 끊지 말고 담당의와 상의하세요. 용량 조절이나 다른 약으로 해결되는 경우가 많습니다.



그림 · 절대 스스로 끊지 마세요(설명용 그림)

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 안전 안내 — 베타차단제 임의 중단 금지 · 반드시 담당의 상담

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료 때 이렇게 상의하세요

궁금하거나 불편한 점이 있으면, 끊는 대신 다음을 물어보세요

+ 이렇게 하세요

- "제 심장 기능이면 이 약이 꼭 필요한가요?" 물어보기
- 피로·어지럼 등 불편한 증상을 솔직히 말하기
- 집에서 잰 혈압·맥박 기록을 가져오기
- 약을 빠뜨린 날이 있으면 의사에게 알리기
- 조정이 필요하면 의사 지시에 따라 서서히

vs

– 이것은 피하세요

- 인터넷·이 자료만 보고 스스로 끊기
- 몸이 괜찮다고 임의로 거르거나 줄이기
- 부작용이 있다고 말없이 복용 중단
- 남의 사례를 내 경우와 똑같이 적용하기
- 다음 진료까지 불편을 참고 방치하기

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 실천 안내 — 약 조정은 진료실에서, 함께 결정합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 핵심 6가지

베타차단제, 끊을지는 나 혼자가 아니라 담당의와 함께 정합니다

01 베타차단제는 심장을 쉬게 하는 심장 보호약입니다

02 ABYSS는 "1년 뒤 끊어도 되나"를 물은 대규모 연구입니다

03 ABYSS에서는 중단의 안전성이 입증되지 않았지만, REBOOT·REDUCE-AMI(심장 기능이 보존된 분)에서는 새로 시작하는 장기 이득이 확인되지 않았습니다

04 끊으면 혈압·맥박이 오르고 삶의 질은 좋아지지 않음

05 갑자기 끊으면 반동 현상 위험 — 스스로 중단 금지

06 불편하면 끊지 말고 반드시 담당의와 상의하세요

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · Take-home — 임의 중단 금지, 조정은 담당의와 함께

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

환자와 보호자를 위한 설명자료입니다. 진단과 처방은 담당 의료진과 상의하세요.

참고한 자료

ABYSS(NEJM 2024) · REBOOT(NEJM 2025) · REDUCE-AMI(NEJM 2024)

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요